Árbol de decisión — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. ee88b18c

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿Existen signos de compromiso medular (mielopatía)?

- **SÍ** — Alteración de marcha, hiperreflexia, signo de Hoffmann o Clonus positivos → **8 Mielopatía Espondilótica Cervical**
- **NO** — Sin signos de mielopatía → sin hipótesis

todas →

2 ¿Hubo un mecanismo de aceleración-desaceleración reciente (latigazo cervical)? 📝 G2, G3 · R1

- **SÍ** — ROM cervical significativamente reducido y síntomas de hiperalerta → **5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)**
- **NO** — Sin mecanismo traumático → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

Desvío desde el paso 3 si «SÍ»

3b ¿Rasgos neuropáticos, déficit de conducción o ninguno? Pueden coexistir; si el inicio fue traumático, el paso 2 ya añade el latigazo. 📝 R3, R5, R12

- **DOLOR RADICULAR** → **12 Dolor Radicular Cervical**
- **RADICULOPATÍA** → **3 Radiculopatía Cervical**
- **AMBOS** → **12 Dolor Radicular Cervical** + **3 Radiculopatía Cervical**
- **AURA MIGRAÑOSA** → sin hipótesis
- **FALLA LA MÉDULA** → **8 Mielopatía Espondilótica Cervical**

SÍ ↑

3 ¿El dolor baja por el brazo y es peor que el del cuello? 📝 R2, R3, R4, R5

- **SÍ** — Test de Spurling positivo, ULNT1 positivo o alivio con abducción del hombro → **→ desvío 3b**
- **NO** — Sin irradiación predominante al brazo → sin hipótesis

NO →

4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?

📝 R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13

- **Cefalea unilateral** — Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2 → **4 Cefalea Cervicogénica**
- **Cefalea primaria** — Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir) → sin hipótesis
- **Dolor en hombro/escápula** — Restricción de movilidad de 1ª costilla → **10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)**
- **Dolor local/inespecífico** — Sin cefalea ni irradiación dominante → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 4b, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4b: viene del paso 4

4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).
📝 R14, R15, R16, R17, R20

- **MAREO CERVICOGÉNICO** — Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5° → **13 Mareo Cervicogénico**
- **VESTIBULAR** — Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción → sin hipótesis
- **NO** — Sin mareo → sin hipótesis

todas →

5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?

- **Déficit de Movilidad** — ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles → **1 Disfunción Articular Cervical**
- **Déficit de Coordinación** — CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado → **2 Disfunción Neuromuscular Cervical**
- **Déficit de Fuerza** — Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical → **6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular**
- **Déficit de Resistencia** — Fatiga muscular en actividades funcionales → **11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular**
- **Déficit Postural** — Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente → **9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica**
- **Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro** → **7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico**

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica. 📝 R1, R18, R19

- **CRANEOCERVICAL (C1–2)** — Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría → **14 Dolor Cervical Idiopático**
- **FACETA CERVICAL** — Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa → **14 Dolor Cervical Idiopático**
- **CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA** — Giro libre al inicio pero excursión final limitada → **14 Dolor Cervical Idiopático**
- **NINGUNO** — No es idiopático o no se localiza → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0